

Số: 117/BC-KD

Gia Định, ngày 15 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả giám sát Dược lâm sàng ngoại trú và hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú tháng 8 năm 2026

Căn cứ Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược;

Căn cứ Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Khoa Dược năm 2026;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động Dược lâm sàng năm 2026;

Căn cứ hoạt động giám sát Dược lâm sàng ngoại trú và hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú tháng 8 năm 2026.

Khoa Dược báo cáo kết quả giám sát Dược lâm sàng ngoại trú và hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú tháng 8 năm 2026 như sau:

I. TỔNG QUAN

1.1. Mục tiêu

Bảo đảm thực hiện đúng các quy định về kê đơn và quy chế kê đơn thuốc ngoại trú tại Bệnh viện;

Nhằm phát hiện, thống kê và phân tích các sai sót trong kê đơn điều trị ngoại trú tại cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều trị ngoại trú.

Tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn trong sử dụng thuốc ngoại trú.

1.2. Phương pháp thực hiện

Tiền kiểm:

Bước 1: Thẩm định đơn thuốc ngoại trú (dược lâm sàng, dược sĩ cấp phát duyệt đơn trực tiếp) về:

- Quy chế kê đơn

- Tính hợp lý trong sử dụng thuốc (chỉ định, liều dùng, đường dùng, cách dùng, chống chỉ định, độ dài đợt điều trị,...) theo các tài liệu hướng dẫn:

- + Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bộ Y tế.
- + Dược thư Quốc gia Việt Nam phiên bản hiện hành.
- + Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất.
- + Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc biệt dược gốc (nếu có).

+ Các tương tác thuốc - thuốc căn cứ theo Quyết định 5948/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2021 về việc Ban hành danh mục tương tác thuốc chống chỉ định trong thực hành lâm sàng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bước 2: Can thiệp (nếu cần), ghi nhận kết quả can thiệp.

Hậu kiểm:

Dược sĩ lâm sàng hậu kiểm các đơn thuốc ngoại trú trên phần mềm bệnh viện, thống kê và ghi nhận các vấn đề liên quan đến thuốc (DRP) và trao đổi với bác sĩ.

Tư vấn sử dụng thuốc:

Dược sĩ lâm sàng tư vấn người bệnh trực tiếp tại phòng tư vấn sử dụng thuốc và ghi nhận các vấn đề trong quá trình điều trị của người bệnh.

II. KẾT QUẢ

2.1. Tổng quan

Tổng quan kết quả giám sát Dược lâm sàng ngoại trú và hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú tháng 8 như sau:

Bảng 1. Tổng quan hoạt động giám sát kê đơn thuốc ngoại trú và tư vấn

Hoạt động	Kết quả	
	Số lượng (đơn)	Tỷ lệ (%)
Tổng số đơn thuốc ngoại trú tháng 08/2026	87.419 đơn	
<i>Số lượng đơn can thiệp</i>	15	0,016%
<i>Can thiệp được chấp nhận</i>	13	86,7%
<i>Can thiệp không được chấp nhận</i>	02	13,3%
Giám sát đơn thuốc hậu kiểm	309 đơn	
<i>Đơn thuốc có ≥ 1 DRP</i>	43	13,9%

Hoạt động	Kết quả	
	Số lượng (đơn)	Tỷ lệ (%)
<i>Tổng số DRP ghi nhận</i>	50 DRP	
Giám sát thuốc theo chuyên đề	17.743 đơn	
<i>Số đơn chưa hợp lý</i>	1.784	10,1%
Tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú	474 người bệnh	

2.2. Giám sát tiền kiểm

Trong tháng 8/2026, Dược lâm sàng ngoại trú và cấp phát thuốc tiếp tục thực hiện giám sát đơn ngoại trú tại các khu vực cấp phát thuốc. Qua quá trình giám sát, ghi nhận 14 đơn thuốc có các vấn đề liên quan đến thuốc và thực hiện can thiệp trực tiếp với bác sĩ; 01 trường hợp hội chẩn Dược lâm sàng ngoại trú về dị ứng thuốc. Trong đó, có 13 can thiệp/ý kiến hội chẩn được chấp nhận (đạt 86,7%), 02 can thiệp không được chấp nhận (13,3%).

Phân loại các vấn đề liên quan đến thuốc phát hiện qua hoạt động tiền kiểm được thể hiện trong **Bảng 2**.

Bảng 2. Phân loại các vấn đề liên quan đến thuốc qua hoạt động tiền kiểm

Nội dung can thiệp	Số lượng	Tỷ lệ
Trùng thuốc	03	20,0%
Sai thuốc	02	13,3%
Hội chẩn dị ứng thuốc	01	6,7%
Liều dùng cao hơn khuyến cáo	01	6,7%
Đợt điều trị dài hơn khuyến cáo	01	6,7%
Các vấn đề khác <i>Nhằm số lượng thuốc được chỉ định</i>	07	46,6%
Tổng	15	100%

Một số vấn đề can thiệp điển hình:

Về độ dài đợt điều trị

Người bệnh nữ, 63 tuổi, chẩn đoán trào ngược dạ dày, thực quản (K21), viêm dạ dày (K29) được chỉ định Domperidon 10mg (Modom's) 01 viên x 2 lần/ngày

trong 28 ngày. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của nhà sản xuất, liều Domperidon trên người lớn từ 12 tuổi và cân nặng từ 35 kg có thể dùng liều 10mg x 3 lần/ngày với thời gian điều trị không nên vượt quá một tuần (07 ngày). Dược lâm sàng trao đổi với bác sĩ giảm độ dài đợt điều trị xuống tối đa 07 ngày. Bác sĩ đồng ý điều chỉnh với chế độ liều 01 viên x 3 lần/ngày trong 07 ngày.

Về liều thuốc

Người bệnh nữ, 74 tuổi, chẩn đoán đái tháo đường type 2 (E11.9) được chỉ định Linagliptin 5mg (Tridjantab) 01 viên x 2 lần/ngày. Theo khuyến cáo, liều Linagliptin tối đa là 5mg/ngày. Dược lâm sàng trao đổi và thông tin với bác sĩ giảm liều Linagliptin xuống 5mg/ngày. Bác sĩ đồng thuận với ý kiến dược sĩ.

(Chi tiết các nội dung can thiệp khác đính kèm Phụ lục 1)

2.3. Giám sát hậu kiểm

Trong tháng 8/2026, Dược lâm sàng ngoại trú đã thực hiện rà soát hậu kiểm đơn thuốc trong khoảng thời gian từ ngày 15/08/2026 đến ngày 31/08/2026, với tổng cộng 309 đơn thuốc được đánh giá. Kết quả ghi nhận 43 đơn thuốc có ít nhất một vấn đề liên quan đến thuốc, chiếm 13,9% tổng số đơn thuốc được hậu kiểm. Tổng cộng phát hiện 50 DRP, cho thấy một số đơn thuốc vẫn còn tồn tại các vấn đề cần được tiếp tục theo dõi, đánh giá và can thiệp nhằm góp phần nâng cao tính hợp lý, an toàn và hiệu quả trong sử dụng thuốc cho người bệnh ngoại trú.

Phân loại vấn đề phát hiện qua hậu kiểm được thể hiện trong **Bảng 3**.

Bảng 3. Phân loại các vấn đề liên quan đến thuốc qua hoạt động hậu kiểm

Vấn đề liên quan đến thuốc	Số lượng	Tỷ lệ
<i>Lựa chọn thuốc</i>		
Không có chỉ định	07	14,0%
Không phù hợp với mã ICD-10	05	10,0%
Nhiều thuốc cho cùng chỉ định	02	4,0%
Có chống chỉ định	01	2,0%
Đường dùng, dạng bào chế chưa phù hợp	01	2,0%
Vấn đề khác liên quan đến lựa chọn thuốc	01	2,0%
<i>Liều dùng thuốc và độ dài đợt điều trị</i>		
Tần suất dùng nhiều hơn khuyến cáo	14	28,0%
Liều dùng cao hơn khuyến cáo	11	22,0%

Vấn đề liên quan đến thuốc	Số lượng	Tỷ lệ
Liều dùng thấp hơn khuyến cáo	07	14,0%
Độ dài đợt điều trị không phù hợp	01	2,0%
Tổng cộng	50 DRP	

Một số vấn đề liên quan đến thuốc điển hình:

- Đối với thuốc Etoricoxib, chỉ định liều 90mg x 1 viên/ngày cho chẩn đoán thoái hoá khớp. Tuy nhiên, liều khuyến cáo trong điều trị thoái hoá khớp (viêm xương khớp) của Etoricoxib là từ 30 - 60mg (tối đa 60mg/ngày). Liều 90mg sử dụng trong viêm khớp dạng thấp, giảm đau trong các cơn đau vừa do phẫu thuật nha khoa.

- Đối với thuốc Trimetazidin, chỉ định mã ICD-10 I20.0 là “Cơn đau thắt ngực không ổn định” không phù hợp. Trimetazidin được sử dụng điều trị triệu chứng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ hoặc người bệnh không dung nạp với các liệu pháp điều trị khác (thuốc chống chỉ định bệnh Parkinson, run, hội chứng chân không nghỉ và các rối loạn vận động có liên quan khác), mã ICD-10 phù hợp là I20.8/I20.9.

- Liên quan đến liều dùng thuốc, các DRP phổ biến là tần suất dùng thuốc chỉ định nhiều hơn khuyến cáo, gặp ở các thuốc có dạng bào chế phóng thích kéo dài hoặc các thuốc có thời gian bán thải dài như Amlodipin, Nifedipin dạng bào chế LA (Long-acting), Felodipin dạng bào chế MR (Modified Release).

(Chi tiết các vấn đề liên quan đến thuốc hậu kiểm đính kèm Phụ lục 2)

2.4. Giám sát chuyên đề

Trong tháng 8/2026, Dược lâm sàng ngoại trú đã thực hiện rà soát theo chuyên đề về liều và tần suất sử dụng một số thuốc trong điều trị bệnh lý tim mạch có thời gian bán thải dài và dạng bào chế đặc biệt bao gồm: Amlodipin 5mg (Amlodipine 5mg Cap); Nifedipin 30mg (NifeHexal 30 LA); Telmisartan 40mg (Savi Telmisartan 40); Telmisartan 80mg (Agimstan 80) và Felodipin 5mg (Flodicar 5mg MR). Kết quả giám sát và rà soát được thể hiện như **Bảng 4**.

Bảng 4. Kết quả giám sát chuyên đề

Vấn đề liên quan đến thuốc	Số lượng	Tỷ lệ (*)
(1) Amlodipin 5mg (Amlodipine 5mg Cap) – Viên nang		
<i>Tổng số đơn rà soát</i>	<i>7.508 đơn</i>	
Tổng số đơn chưa hợp lý	389	5,2%

Vấn đề liên quan đến thuốc	Số lượng	Tỷ lệ (*)
<i>Tần suất dùng 2 lần/ngày</i>	386	99,2%
<i>Chỉ định bẻ đôi viên thuốc</i>	05	1,3%
(2) Nifedipin 30mg (NifeHexal 30 LA) – Viên nén bao phim		
<i>Tổng số đơn rà soát</i>	392 đơn	
Tổng số đơn chưa hợp lý	288	73,5%
<i>Tần suất dùng 2 lần/ngày</i>	288	100%
<i>Tần suất dùng 3 lần/ngày</i>	03	1,0%
<i>Liều dùng cao hơn khuyến cáo: 30mg x 2 viên x 2 lần/ngày (liều khuyến cáo tối đa là 90mg/ngày)</i>	07	2,4%
<i>Chỉ định bẻ đôi viên thuốc</i>	01	0,3%
(3) Telmisartan 40mg (Savi Telmisartan 40mg) – Viên nén bao phim		
<i>Tổng số đơn rà soát</i>	2.092 đơn	
Tổng số đơn chưa hợp lý	110	5,3%
<i>Tần suất dùng 2 lần/ngày</i>	110	100%
(4) Telmisartan 80mg (Agimstan 80) – Viên nén		
<i>Tổng số đơn rà soát</i>	1.370 đơn	
Tổng số đơn chưa hợp lý	15	1,1%
<i>Tần suất dùng 2 lần/ngày</i>	14	93,3%
<i>Liều cao hơn khuyến cáo: 80mg x 2 lần/ngày (liều khuyến cáo tối đa 80mg/ngày)</i>	01	6,7%
(5) Felodipin 5mg (Flodicar 5mg MR) – Viên nén bao phim		
<i>Tổng số đơn rà soát</i>	6.381 đơn	
Tổng số đơn chưa hợp lý	982	15,4%
<i>Tần suất dùng 2 lần/ngày</i>	956	97,4%
<i>Chỉ định bẻ đôi viên thuốc</i>	26	2,6%

(*) **Ghi chú:** Một đơn thuốc có thể có nhiều DRP, do đó, tổng tỷ lệ các vấn đề liên quan đến thuốc có thể > 100%.

Nhận xét:

Tổng cộng 17.743 đơn thuốc được rà soát liên quan đến chế độ liều và tần suất sử dụng đối với 05 thuốc, ghi nhận tổng cộng 1.784 đơn chưa phù hợp (chiếm 10,1% tổng số đơn giám sát) với 1.797 DRP.

Các thuốc có thời gian bán thải dài như Amlodipin (thời gian bán thải 30 – 40 giờ) hay Telmisartan (thời gian bán thải > 20 giờ) và các thuốc có dạng bào chế đặc biệt của Felodipin (dạng bào chế MR – Modified release: phóng thích có kiểm soát) hay Nifedipin (dạng bào chế LA – Long acting: phóng thích kéo dài): Cần nhắc sử dụng các thuốc hạ huyết áp này với tần suất 01 lần/ngày nhằm duy trì hiệu quả hạ huyết áp trong 24 giờ và đơn giản hóa phác đồ, góp phần tăng tuân thủ điều trị cho người bệnh.

Về liều dùng:

- Đối với Nifedipin 30mg (NifeHexal 30 LA): liều dùng trong điều trị tăng huyết áp khuyến cáo là 01 viên 30mg một lần mỗi ngày. Nếu cần có thể tăng liều lên tối đa 90mg một lần mỗi ngày.

- Đối với Telmisartan: liều dùng trong điều trị tăng huyết áp khuyến cáo duy trì 40mg một lần mỗi ngày. Nếu cần có thể tăng liều lên tối đa 80mg một lần mỗi ngày.

2.5. Hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú

Hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú giúp người bệnh nâng cao nhận thức tuân thủ và an toàn khi sử dụng thuốc. Từ đó, đồng hành cùng bác sĩ điều trị trong nâng cao hiệu quả điều trị, sử dụng thuốc đúng cách và an toàn.

Tổng kết hoạt động tư vấn sử dụng thuốc tháng 8 với tổng số lượt tư vấn là 474 người bệnh, bao gồm các vấn đề sau:

Bảng 5. Các nội dung tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú

Các nội dung tư vấn	Số lượng	Tỷ lệ
Phân loại, chia thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc cơ bản	410	86,4%
Hướng dẫn sử dụng thuốc cho người bệnh đặc biệt (khiếm thị, khiếm thính, mù chữ,...)	06	1,3%
Hướng dẫn sử dụng insulin (bơm tiêm, bút tiêm)	26	5,5%

Khắc phục các sự cố liên quan đến hư hỏng bơm tiêm, bút tiêm insulin	08	1,7%
Hướng dẫn sử dụng các dụng cụ hít hô hấp, nhỏ mắt, nhỏ tai, xịt mũi	16	3,4%
Can thiệp, xử trí các ADR, tư vấn tuân thủ dùng thuốc	08	1,7%

Một số trường hợp tư vấn điển hình trong tháng 8:

- Người bệnh vệ sinh đầu ngâm bình hít bột khô Turbuhaler dưới vòi nước. Tư vấn lại cho người bệnh hiểu về dạng thuốc trong bình hít là dạng bột khô, cần tránh nước, môi trường ẩm ướt. Hướng dẫn vệ sinh đầu ngâm bằng khăn giấy khô.

- Người bệnh tiêm insulin ở vùng bụng nhưng không thay đổi vị trí tiêm, dẫn đến tình trạng chai cứng, bầm tím vùng tiêm, có hiện tượng loạn dưỡng mỡ (Hình 1). Dược lâm sàng hướng dẫn lại kỹ thuật tiêm và các biện pháp giảm thiểu đau vị trí tiêm, tư vấn người bệnh thay đổi vị trí tiêm mỗi lần tiêm thuốc.



Hình 1. Người bệnh gặp phải biến cố loạn dưỡng mỡ

- Người bệnh không tuân thủ dùng thuốc, Dược lâm sàng khai thác việc uống thuốc phát hiện người bệnh chỉ uống thuốc tăng huyết áp khi đo chỉ số huyết áp tăng cao, không uống thuốc theo đơn bác sĩ. Dược sĩ tư vấn cho người bệnh hiểu về bệnh lý tăng huyết áp là một bệnh mạn tính cần kiểm soát thuốc lâu dài và chỉ ra các biến cố có thể gặp phải nếu không tuân thủ dùng thuốc.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trong tháng 8/2026, hoạt động Dược lâm sàng ngoại trú được triển khai thường xuyên thông qua tiền kiểm, hậu kiểm, giám sát chuyên đề và tư vấn sử dụng thuốc. Hoạt động tiền kiểm ghi nhận 15 vấn đề liên quan đến thuốc, với 86,7% can thiệp được bác sĩ chấp nhận; hậu kiểm 309 đơn phát hiện 43 đơn có DRP (13,9%), tổng cộng 50 DRP. Giám sát chuyên đề trên 17.743 đơn thuốc của 05 thuốc tim mạch ghi nhận 1.784 đơn chưa phù hợp (10,1%), chủ yếu liên quan đến tần suất sử dụng cao hơn khuyến cáo ở các thuốc có thời gian bán thải dài hoặc

dạng phóng thích kéo dài. Bên cạnh đó, phòng tư vấn đã thực hiện 474 lượt tư vấn, tập trung vào hướng dẫn sử dụng thuốc, insulin, dụng cụ hít, xử trí ADR và tuân thủ điều trị. Kết quả cho thấy hoạt động Dược lâm sàng đã góp phần phát hiện, can thiệp các vấn đề liên quan đến thuốc và nâng cao tính hợp lý, an toàn trong sử dụng thuốc ngoại trú; đồng thời cần tiếp tục tăng cường rà soát kê đơn và nâng cao chất lượng tư vấn, đặc biệt đối với các thuốc có dạng bào chế đặc biệt và người bệnh có khó khăn trong sử dụng thuốc.

Trong thời gian tới, kiến nghị tiếp tục duy trì hoạt động tiền kiểm và hậu kiểm đơn thuốc ngoại trú, ưu tiên các nhóm thuốc và vấn đề có tần suất phát hiện cao; tăng cường trao đổi, phản hồi kết quả hậu kiểm đến bác sĩ nhằm phòng ngừa tái diễn các DRP. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chuyên đề giám sát sử dụng thuốc dựa trên những vấn đề thực tế ghi nhận tại bệnh viện và duy trì hoạt động tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp sử dụng insulin, thuốc dạng bào chế đặc biệt, dụng cụ hít và người bệnh có nguy cơ không tuân thủ. Kết quả giám sát và tư vấn cần được tổng hợp, theo dõi định kỳ để đánh giá hiệu quả can thiệp và làm cơ sở xây dựng các giải pháp cải tiến chất lượng sử dụng thuốc tại Bệnh viện.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát Dược lâm sàng ngoại trú và hoạt động tư vấn sử dụng thuốc ngoại trú tháng 08 năm 2026 của Khoa Dược./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- HĐT&ĐT, P. KHTH, P. QLCL (để báo cáo);
- Các khoa, phòng (để biết);
- Dược lâm sàng ngoại trú (thực hiện);
- Lưu: KD (NDA).

TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Thị Anh Thi

DUYỆT BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Minh Kiều